

LA RELATION MEDECIN-MALADE

Pr SEGHIR

I. INTRODUCTION

La relation médecin-malade est spécifique car elle a pour premier objet le corps du malade, mais la parole est le premier moyen thérapeutique, donc source d'incompréhension et d'erreurs.

La relation médecin-malade est une relation asymétrique. Elle naît de la demande d'un patient souffrant adressé à un médecin ayant le savoir sur la maladie : le malade est passif alors que le médecin doit prendre la responsabilité de la démarche de soin.

La relation médecin-malade n'est ni une relation amicale, ni familiale, ni commerciale. C'est une relation de confiance qui s'inscrit dans le cadre d'une pratique éthique.

Une relation médecin-patient harmonieuse doit permettre :

- une démarche diagnostique ;
- l'amélioration de la qualité de vie du patient ;
- la prise en compte du point de vue du patient ;
 - une bonne observance thérapeutique ;
- un exercice médical le plus confortable possible.

II. ASPECTS THEORIQUES

Le concept de **transfert** : constitué de l'ensemble des réactions affectives conscientes et inconscientes que le patient éprouve à l'égard de son médecin. Il répond de désirs inconscients, de désirs insatisfaits, de modalités relationnelles vécues dans l'enfance, qui vont s'actualiser et s'immiscer dans le rapport qui s'établit avec le médecin.

Le **contre-transfert** désigne les mouvements affectifs, l'influence du malade sur les sentiments inconscients du médecin :

- Un contre-transfert positif permet une relation médecin-malade de qualité, le développement d'une empathie et une action thérapeutique efficace.
- Un contre-transfert négatif induit une agressivité du soignant qui peut induire un échec de la relation.
- Une absence de contre-transfert tend à susciter une froideur du soignant.

Il est donc nécessaire pour le médecin d'être capable de reconnaître les sentiments du malade qui pourraient entraver les démarches diagnostiques et thérapeutiques.

III. MODELES DE RELATION MEDECIN-MALADE

1. Modèle traditionnel : paternaliste

Le médecin est décideur : il doit proposer la solution la mieux adaptée à la maladie. Le médecin est aussi décideur de la qualité de vie de vie du patient.

Inconvénient :

- Appropriation par le médecin des valeurs du patient.
- Satisfaction du patient vis-à-vis de ce modèle.
- Modèle choisi par le médecin.

Avantage :

- Porter son agressivité sur le médecin.
- Ne pas avoir à faire de choix.

2. Modèle informatif

Le patient est décideur : Le médecin doit proposer les différentes options avec leurs avantages et leurs inconvénients et le patient prend sa décision.

Limite :

- Compréhension imparfaite des propositions médicales.
- Barrage lié aux représentations.
- Qui a la capacité d'une telle décision ?
- Qui souhaite une telle décision ?

Caractéristiques des modèles paternaliste et informatif

Modèle	Paternaliste	Informatif
Synonymes	Médecin décideur	Patient décideur
Principe	Bienveillance	Autonomie
Culture	Latine	Anglo-Saxonne
Avantages	Protection/souffrance physique et psychique. Réduction anxiété	Liberté/décision Choix de vie
Risques	Pouvoir médical Fausse idée toute puissance médecin	Indifférence Irresponsabilité du médecin
Fondements	Droit romain	Common Law

3. La décision partagée

- Prend en compte des aspects des 2 modèles paternaliste et informatif.
- Comporte 3 étapes :

1. L'information :

- Comprendre le motif de consultation et aboutir à un diagnostic à partir d'une technique définie.
- Présenter les bénéfices et inconvénients des différentes options.
- Méthodologie scientifique et validée.

2. La délibération :

Aider le patient à :

- Révéler ses préférences
- Faire émerger ses valeurs/maladie et traitements
- Se mettre en situation
- S'interroger / famille, travail, social...
- Préciser l'impact du traitement sur le mode de vie.

3. La décision :

- Décision finale prise au cours d'un second entretien.
- Délai de 8 jours minimum.
- Documents informatifs pour aider à la décision.
- Demander un second avis si besoin.

➤ Difficultés :

- Anxiété associée au choix décisionnel
- Asymétrie de connaissance et d'expérience
- Interprétation du patient
- Médecins confondent avec modèle informatif
- Sentiment d'incompétence des jeunes médecins

=> Approche nécessitant un apprentissage

IV. DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

1. Les mécanismes de défense du malade

On peut considérer les mécanismes de défense du malade comme des mécanismes d'adaptation : face à une réalité nouvelle, un traumatisme, ou un événement stressant, l'individu développe une série de réactions qui lui permettent de faire face (coping ability).

Le déni

En dépit de l'évidence des indices, le malade refuse de reconnaître la réalité.

Le déplacement

Le malade focalise sa peur sur une autre réalité, en transférant l'angoisse liée à sa maladie, sur un élément substitutif par exemple, il ne parle que de sa peur des effets secondaires du traitement, ou d'un symptôme mineur sans jamais évoquer son cancer.

La régression

Le malade se replie sur lui-même et sur ses symptômes, demandant à être protégé et pris en charge sur un mode parental.

La projection agressive

Le malade réagit de façon agressive et revendicatrice, attaquant ses proches et les soignants sur un mode paranoïaque. Cette agressivité exprimée au travers de « l'incompétence » des médecins et de l'inadéquation affective de ses proches est la seule défense du malade contre son angoisse.

Sublimation

Le malade prend appui sur l'épreuve qu'il endure pour tenter de la dépasser et rendre constructif son rapport à l'adversité : il s'attache à créer une association, à écrire un livre ou à se tourner vers l'autre dans une réelle forme d'altruisme. Ce désir de consolider sa propre fragilité par le don de soi donne un sens à sa maladie.

B/ Les mécanismes de défense des soignants

Face à souffrance du malade et à la difficulté à contrôler certains symptômes, les soignants vont mettre en place des mécanismes de défense pour se préserver d'une réalité trop douloureuse.

Le mensonge

Le mensonge est souvent mécanisme de défense de « l'urgence » qui évite la montée de l'angoisse, mais qui empêche le malade de mettre en place ses mécanismes d'adaptation et donc de s'ajuster progressivement à la réalité. Une évolution défavorable de la maladie risque de compromettre toute relation de confiance.

La fuite en avant

Surestimant les capacités psychiques du patient et méconnaissant ses mécanismes d'adaptation, certains soignants devancent les questions et brûlent les étapes. Ils s'empressent de tout dire, angoissés par le poids d'un savoir trop lourd à porter, dont ils voudraient se libérer.

La fausse réassurance

En optimisant des résultats alors que le patient lui-même n'y croit plus, le soignant cherche à retarder la confrontation à la réalité.

La rationalisation

Par un discours très technique et totalement incompréhensible pour le malade, le soignant se retranche derrière son savoir. Ainsi il parvient à éviter le dialogue, apportant aux questions trop embarrassantes des réponses obscures.

L'évitement

Le médecin peut craindre d'être mis en difficulté par les questions du malade, par sa quête d'espoir, par la confrontation à sa dégradation physique. Il cherche alors à réduire au minimum le contact physique et psychique avec le malade :

- En prenant comme interlocuteur exclusif un tiers (famille, infirmière).
- En limitant le temps de visite, d'écoute et d'examen.
- En se retranchant derrière les examens para cliniques, la tenue du dossier.